AULA DE SALUD COMUNITARIA · PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2027

Indicadores y evaluación: un plan que pueda evaluarse

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Propuesta docente en revisión: 31/10/2026. Pendiente de validación institucional.

Fichas de indicador con tiempo cero, revisión de actuaciones grupales, seguimiento y evaluación, registros de actividad y matriz de evaluación.

Qué aprenderemos

- Construir una ficha de indicador completa, con tiempo cero, meta y responsable de medición.
- Revisar una actuación de educación para la salud grupal con la lista de comprobación de planificación.
- Distinguir seguimiento y evaluación, y evaluación de proceso, resultados e impacto.
- Reconocer qué puede y qué no puede afirmar un registro de actividad.
- Construir una matriz de evaluación proporcionada y revisarla con la lista de comprobación de evaluación.

Agenda

09:00–09:30
Retorno de la entrega V1: aciertos y errores frecuentes

09:30–10:30
Indicadores: taller de fichas sobre el plan de cada grupo

10:30–11:15
Lista de comprobación de planificación de EpS grupal aplicada a una actividad propuesta para Zagra

11:15–11:45
Descanso

11:45–12:30
Seguimiento y evaluación. Contribución y atribución en un municipio de 843 habitantes. RE-AIM

12:30–13:15
Registros de actividad (RAPS) y taller de matriz de evaluación

13:15–13:45
Lista de comprobación de evaluación de EpS grupal

13:45–14:00
Cierre y presentación del bloque virtual V2

1. Ficha de indicador

Indicadores y evaluación: un plan que pueda evaluarse

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Nombre
Breve y sin ambigüedad

Tipo
Proceso, resultado o impacto

Definición operativa
Qué se cuenta exactamente

Numerador y denominador
Con unidad y población de referencia

Fuente
Registro, encuesta, padrón u otra; quién custodia el dato

Frecuencia
Cuándo se mide

Tiempo cero
Valor de partida y fecha, registrado antes de ejecutar

Meta
Valor esperado al final del periodo y justificación

Responsable de medición
Cargo

Cautelas
Qué no puede concluirse con este indicador

Ejemplo de referencia

La EPVSA asocia cada objetivo estratégico a indicadores de contexto (situación de partida) e indicadores de impacto, muchos procedentes de la Encuesta Andaluza de Salud. Esa lógica, partida y llegada medidas con la misma definición, es la que se pide a cada indicador local. Un indicador autonómico no suele tener resolución municipal: no sirve como tiempo cero de un plan local si no se dispone del dato para el municipio. En Zagra, los indicadores de la tabla anterior se miden en las personas participantes, no en la población: son indicadores de resultado de una actuación. Con 843 habitantes, una encuesta poblacional repetida puede ser factible, pero hay que decidirlo antes de empezar.

Reglas de prudencia

- No promediar porcentajes de actuaciones distintas para obtener un indicador agregado.
- No sumar participantes de varias actividades sin eliminar duplicados.

Indicadores y evaluación: un plan que pueda evaluarse

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

- No usar un indicador de actividad del servicio como indicador de necesidad.
- Si no hay tiempo cero, decirlo y planificar su medición antes de empezar.

2. Lista de comprobación de planificación de EpS grupal

44 ítems en siete secciones: análisis de la situación, objetivos, contenidos y metodología, recursos y logística, cronograma, evaluación, y actores y coordinación. Se aplica en parejas a una actividad grupal propuesta para Zagra (por ejemplo, un taller de alimentación para todas las edades o actividades para cuidadoras). Interesa menos el porcentaje total que las secciones con menor cumplimiento: indican dónde hay que volver antes de ejecutar.

3. Seguimiento y evaluación

¿Estamos haciendo lo que planificamos?
Tipo: Seguimiento de proceso · Compara con: Lo planificado

¿Llega a quien debía llegar y como estaba previsto?
Tipo: Evaluación de proceso · Compara con: El diseño de la actuación

¿Han cambiado los determinantes, conocimientos, conductas o condiciones?
Tipo: Evaluación de resultados · Compara con: El tiempo cero

¿Ha mejorado la salud de la población?
Tipo: Evaluación de impacto · Compara con: El tiempo cero y, si es posible, un territorio de comparación

Contribución y atribución

En un plan local de cuatro años rara vez puede atribuirse un cambio en la salud de la población a las actuaciones del plan: influyen otros factores y el tamaño de la población limita la precisión. Lo razonable suele ser evaluar el proceso con exhaustividad, los resultados intermedios con rigor y el impacto como contribución plausible, declarando los límites. Prometer impacto atribuible que no podrá demostrarse debilita la credibilidad del plan. Zagra lo muestra con claridad: 17 defunciones en 2015 dieron una tasa bruta de 18,9 por mil; con esa población, la variación de un año a otro puede deberse al azar. Un plan local para un municipio de este tamaño debe evaluarse sobre todo por su proceso y por los cambios en las personas participantes.

Dimensiones útiles (marco RE-AIM)

Alcance
¿Qué proporción de la población destinataria participó? ¿Quién quedó fuera?

Efectividad
¿Qué cambió en quienes participaron?

Indicadores y evaluación: un plan que pueda evaluarse

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Adopción
¿Qué entidades y profesionales se sumaron?

Implementación
¿Se hizo lo previsto? ¿Qué se adaptó y por qué?

Mantenimiento
¿Continúa la actuación cuando termina el apoyo inicial?

Preguntas de evaluación para Zagra (ejemplos)

- Alcance: ¿qué proporción de las 198 personas de 65 años o más ha participado en alguna actuación? ¿Han participado hombres y mujeres, y población de nacionalidad extranjera?
- Efectividad: ¿ha disminuido la soledad percibida en las personas incorporadas a la intervención, medida con la misma escala al inicio y en el seguimiento?
- Adopción: ¿cuántos de los activos registrados en Localiza Salud participan en el plan?
- Implementación: ¿se mantuvieron las actividades previstas? ¿Qué se adaptó?
- Mantenimiento: ¿siguen las actuaciones cuando cambia el personal del consultorio o la corporación municipal? En Zagra, el ciclo de 2017-2018 no consta que se completara.

4. Qué dice un registro de actividad

El RAPS (Registro de Actuaciones de Promoción de la Salud) recoge en REDCap las actividades de promoción de la salud que registran los profesionales del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano y permite explorarlas por distrito, unidad y profesional, con procesamiento local en el navegador. Un registro así es una buena fuente para el seguimiento de proceso.

- Puede informar: qué actividades se hicieron, dónde, cuándo, con qué temática y cuántas sesiones.
- Requiere cautela: la exhaustividad depende de que se registre todo lo realizado; sin registro no se puede afirmar que algo no se hizo.
- No puede informar por sí solo: si las personas cambiaron sus conductas o si mejoró su salud.
- Asistencias no equivalen a personas: sin identificador único no se eliminan duplicados.

5. Matriz de evaluación

Pregunta de evaluación
Qué se quiere saber y para qué decisión

Indicador o información
Cuantitativa o cualitativa

Indicadores y evaluación: un plan que pueda evaluarse

SESIÓN 2 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Fuente e instrumento
Registro, cuestionario, entrevista, grupo, observación

Momento
Tiempo cero, durante la ejecución, al final, seguimiento

Responsable
Cargo

Uso previsto
Quién recibirá el resultado y qué podrá decidir con él

Lista de comprobación de evaluación de EpS grupal

33 ítems en seis secciones: planificación de la evaluación, proceso, resultados, impacto, instrumentos, y análisis y uso de resultados. Se aplica a la actividad grupal revisada en la primera parte de la sesión. Ítems que suelen fallar: línea base asegurada antes de empezar, instrumentos pilotados, estrategia para reducir pérdidas de seguimiento y devolución de resultados a participantes.

Criterio de cierre

Cada grupo sale con una ficha de indicador completa y tres preguntas de evaluación de su plan, sabiendo con qué información responderá a cada una y quién usará la respuesta.

Caso de trabajo: Zagra, con datos del expediente territorial y sus fuentes. No incorporar datos personales ni información clínica individual en los trabajos.